

**AVIS SUR LES
MÉDICAMENTS**

nivolumab

OPDIVO 600 mg,

solution injectable pour administration sous-cutanée

Inscription

Adopté par la Commission de la transparence le 4 février 2026

- Oncologie
- Adulte
- Secteur : Hôpital

Synthèse de l'avis

Avis favorable au remboursement uniquement dans les indications actuellement remboursables de OPDIVO 10mg/ml (nivolumab) solution à diluer pour perfusion.

Place dans la stratégie thérapeutique	La place de OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée, est identique à celle de OPDIVO 10mg/ml (nivolumab) solution à diluer pour perfusion.
Service médical rendu (SMR)	Le service médical rendu par OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable, administré par voie sous cutanée, est identique à celui octroyé par la Commission de la Transparence à OPDIVO (nivolumab) 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, pour l'ensemble des indications actuellement inscrites.
Intérêt de santé publique (ISP)	Cette spécialité n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.
Amélioration du Service médical rendu (ASMR)	OPDIVO 600 mg (nivolumab), solution injectable pour administration par voie sous-cutanée n'apporte pas d'amélioration du service médical (ASMR V) par rapport aux présentations de OPDIVO 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion (voie IV) déjà inscrites.
Population cible	L'introduction d'OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée, n'est pas de nature à modifier les populations cibles déjà estimées par la Commission pour OPDIVO (nivolumab) 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion dans les indications actuellement inscrites.
Demande de données	La Commission souhaite être destinataire des résultats finaux notamment la survie globale (SG) de l'étude CheckMate-67T (attendus pour 2026) dans un délai max de 1 an. Sur la base de ces résultats attendus dans un délai maximal de 1 an, la Commission jugera de l'opportunité de réévaluer le médicament.

Sommaire

1.	Contexte	3
2.	Complément d'informations	5
3.	Synthèse des données	6
3.1	Données disponibles	6
3.2	Synthèse des données d'efficacité	6
3.2.1	Etude CheckMate-67T	6
3.3	Profil de tolérance	9
3.3.1	Données issues de l'étude clinique CheckMate-67T	9
3.3.2	Données issues du PBRER et du Plan de Gestion des Risques (PGR)	10
3.3.3	Données issues du RCP	10
4.	Discussion	11
5.	Conclusions de la Commission de la Transparence	12
5.1	Place du médicament dans la stratégie thérapeutique	12
5.2	Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre retenu	12
5.3	Service Médical Rendu	13
5.3.1	Mélanome	13
5.3.2	Traitement adjuvant du mélanome	15
5.3.3	Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC)	16
5.3.4	Carcinome à cellules rénales (CCR)	17
5.3.5	Cancer épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN)	19
5.3.6	Traitement adjuvant du carcinome urothélial	19
5.3.7	Cancer colorectal (CRC) avec déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) ou instabilité microsatellitaire élevée (MSI H)	20
5.3.8	Carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO)	22
5.3.9	Traitement adjuvant du cancer de l'œsophage ou de la jonction œso-gastrique (CO ou CJOG)	22
5.3.10	Adénocarcinome gastrique, de la jonction œsogastrique (JOG) ou de l'œsophage	23
5.4	Amélioration du Service Médical Rendu	24
5.5	Population cible	24
5.6	Demande de données	24
5.7	Autres recommandations de la Commission	25

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr 

Le présent avis est publié sous réserve des droits de propriété intellectuelle

Haute Autorité de santé – Service communication et information

5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00

© Haute Autorité de santé – Février 2026

1. Contexte

Résumé du motif d'évaluation	Inscription d'une nouvelle formulation de OPDIVO (nivolumab)
Précisions	Cette spécialité est un complément de gamme de OPDIVO 10 mg/ml (nivolumab), solution à diluer pour perfusion (I.V.)
Indication concernée par l'évaluation	Périmètre de l'indication concernée par la demande : « Mélanome OPDIVO est indiqué en monothérapie ou en association à l'ipilimumab dans le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique). Par rapport au nivolumab en monothérapie, une augmentation de la survie sans progression (SSP) et de la survie globale (SG) a été établie pour l'association du nivolumab à l'ipilimumab seulement chez les patients avec une expression tumorale faible de PD-L1. Traitement adjuvant du mélanome OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC, ou avec atteinte des ganglions lymphatiques ou une maladie métastatique, et ayant subi une résection complète. Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure. Carcinome à cellules rénales (CCR) OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé après un traitement antérieur. OPDIVO est indiqué en association à l'ipilimumab, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé de pronostic intermédiaire/défavorable. OPDIVO est indiqué en association au cabozantinib, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé. Cancer épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN) OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer épidermoïde de la tête et du cou, en rechute ou métastatique, en progression pendant ou après une chimiothérapie à base de sels de platine. Traitement adjuvant du carcinome urothélial OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints de carcinome urothélial infiltrant le muscle (CUIM) à haut risque de récurrence après exérèse complète, dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$. Cancer colorectal (CRC) avec déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) ou instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H)

	OPDIVO est indiqué en association à l'ipilimumab, dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN ou une instabilité microsatellitaire élevée dans les situations suivantes : – traitement de première ligne du cancer colorectal non résécable ou métastatique (voir rubriques 4.2 et 5.1); – traitement du cancer colorectal métastatique après une chimiothérapie antérieure combinée à base de fluoropyrimidine (voir rubriques 4.2 et 5.1). Carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO) OPDIVO est indiqué en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résécable, récurrent ou métastatique dont les cellules tumorales expriment PDL1 au seuil $\geq 1\%$. Traitement adjuvant du cancer de l'œsophage ou de la jonction œso-gastrique (CO ou CJOG) OPDIVO est indiqué en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œso-gastrique et qui présentent une maladie résiduelle après une radiochimiothérapie néoadjuvante antérieure. Adénocarcinome gastrique, de la jonction œso-gastrique (JOG) ou de l'œsophage OPDIVO est indiqué en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique, de la jonction œso-gastrique ou de l'œsophage avancé ou métastatique, HER-2 négatifs, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score combiné positif (Combined Positive Score : CPS) ≥ 5. »
DCI (code ATC)	nivolumab (L01FF01)
Présentation concernée	OPDIVO 600 mg, solution injectable – 1 flacon de 5 mL (CIP : 34009 551 097 5 4)
Liste concernée	Collectivités (article L.5123-2 du CSP)
Laboratoire	Bristol-Myers Squibb
AMM (Autorisation de mise sur le marché)	Date initiale (procédure centralisée) : 19/06/2015 (OPDIVO 10 mg/ml (nivolumab), solution à diluer pour perfusion I.V.) Rectificatif d'AMM pour intégrer OPDIVO 600 mg, solution injectable pour administration sous-cutanée (objet du présent avis) : 26/05/2025 Spécificités : Plan de Gestion des Risques (PGR) européen
Conditions et statuts	Conditions de prescription et de délivrance – Liste I – Médicament en réserve hospitalière (RH) – Médicament de prescription réservée à certains médecins spécialistes (PRS) : spécialistes en oncologie, ou médecins compétents en cancérologie. – Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (SPT)
Posologie dans l'indication évaluée	La dose recommandée d'OPDIVO solution injectable, en monothérapie est soit de 600 mg de nivolumab toutes les 2 semaines, soit de 1 200 mg toutes les 4 semaines.

	Pour plus de précision, se référer au RCP.
Autres indications de l'AMM	OPDIVO 600 mg est également indiqué : – en association au cisplatine et à la gemcitabine, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résecable ou métastatique, – en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé non résecable ou métastatique après échec d'une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine, – et en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résecable, récurrent ou métastatique, après une chimiothérapie combinée antérieure à base de fluoropyrimidine et de sels de platine. Les indications ci-dessus ne sont pas remboursables. Un avis défavorable au remboursement a été octroyé à OPDIVO 10mg/ ml, solution à diluer pour perfusion dans le traitement en monothérapie des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO) avancé non résecable, récurrent ou métastatique, après une chimiothérapie combinée antérieure à base de fluoropyrimidine et de sels de platine.¹
Evaluation par la Commission	– Calendrier d'évaluation : • Date d'examen : 26 novembre 2025. • Date d'adoption : 10 décembre 2025. • Date d'audition du laboratoire et d'adoption de l'avis définitif : 4 février 2026. • Expertise externe : Non

2. Complément d'informations

Il s'agit d'une demande d'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités de la spécialité OPDIVO 600 mg (nivolumab), solution pour injection par voie sous cutanée, par suite d'une modification de l'autorisation de mise sur le marché de OPDIVO (nivolumab) obtenue le 26/05/2025 pour la mise à disposition d'une nouvelle forme pharmaceutique (solution pour injection), un nouveau dosage (600 mg) et une nouvelle voie d'administration (voie sous-cutanée, S.C.). Cette spécialité est un complément de gamme de la spécialité OPDIVO, 10 mg/mL (nivolumab), solution à diluer pour perfusion (I.V.). Elle partage toutes les indications approuvées dans les tumeurs solides pour lesquelles OPDIVO solution à diluer pour perfusion (I.V.) est administré en monothérapie (y compris en traitement d'entretien après une thérapie combinée) ou en association avec une chimiothérapie ou le cabozantinib, à condition que la dose recommandée de nivolumab soit de 240 mg toutes les deux semaines (Q2W) et/ou 480 mg toutes les quatre semaines (Q4W).

Certaines indications de OPDIVO, 10 mg/mL (nivolumab), solution à diluer pour perfusion (I.V.), n'ont pas été octroyées à la spécialité OPDIVO 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée. Il s'agit des indications pédiatriques (à partir de 12 ans dans le mélanome), l'indication dans le lymphome de Hodgkin, et les indications avec une posologie toutes les 3 semaines. Il s'agit notamment du carcinome hépatocellulaire, du carcinome épidermoïde de l'œsophage en association avec l'ipilimumab, du mésothéliome pleural malin ainsi que du cancer bronchique non à petites cellules lorsqu'il est traité en situation néoadjuvante seule ou dans une séquence néoadjuvante-adjuvante, y compris l'association de l'ipilimumab à une chimiothérapie dans cette même pathologie.

¹ Avis de la CT du 21 Juillet 2021- OPDIVO dans le traitement en monothérapie des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO) avancé non résecable, récurrent ou métastatique, après une chimiothérapie combinée antérieure à base de fluoropyrimidine et de sels de platine.

3. Synthèse des données

3.1 Données disponibles

L'évaluation de OPDIVO 600 mg (nivolumab) solution injectable pour administration par voie sous-cutanée repose sur l'étude de non-infériorité CheckMate-67T, de phase 3, multicentrique, randomisée, en ouvert, en groupe parallèle, réalisées chez des patients atteints d'un carcinome rénal à cellules claires avancé ou métastatique ayant précédemment reçu un traitement systémique, dont l'objectif principal était de démontrer la non-infériorité de OPDIVO administré par voie sous cutanée versus OPDIVO administré par voie intraveineuse, sur les critères de concentration sérique moyenne du nivolumab au cours des 28 premiers jours ainsi que de concentration sérique résiduelle à l'état d'équilibre.

Les résultats d'efficacité de l'étude de pharmacocinétique CheckMate-8KX, de phase 1/2 dont l'objectif principal était d'évaluer OPDIVO administré par voie sous cutanée (avec ou sans hyaluronidase recombinante PH20 [rHuPH20]) chez des patients atteints d'une tumeur nécessitant un traitement par OPDIVO ne seront pas présentés en raison de leur caractère exploratoire.

3.2 Synthèse des données d'efficacité

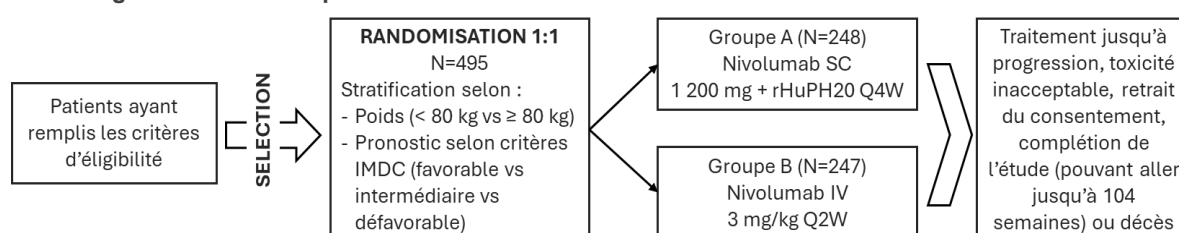
3.2.1 Etude CheckMate-67T

Objectif et schéma de l'étude

Il s'agit d'une étude de phase 3, comparative, randomisée, ouverte, multicentrique, dont l'objectif était de démontrer la non-infériorité du nivolumab administré par voie sous-cutanée (SC) par rapport au nivolumab administré par voie intraveineuse (IV) en termes de bioéquivalence chez les patients atteints d'un carcinome rénal à cellules claires avancé ou métastatique ayant précédemment reçu au moins un traitement antérieur systémique.

L'étude a débuté le 24/05/2021 (1^{er} patient inclus), l'analyse principale a eu lieu le 21/08/2023 et l'analyse de suivi a eu lieu le 18/03/2024.

Figure 1 : Design de l'étude clinique CheckMate-67T



IMDC : International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium, IV : intra-veineux, SC : sous-cutané.

Traitements reçus

Un total de 495 patients a été randomisé (ratio d'allocation 1 : 1) pour recevoir :

- Groupe nivolumab SC (n =248) : Nivolumab 600mg, solution injectable pour administration par voie SC à une dose de 1 200 mg toutes les 4 semaines (± 3 jours) au jour 1 de chaque cycle de traitement, jusqu'à progression, toxicité inacceptable, retrait de consentement, complétion de l'étude (pouvant aller jusqu'à 104 semaines) ou décès.
- Groupe nivolumab IV (n = 247) : Nivolumab 240 mg administré en perfusion IV de 30 minutes à une dose de 3mg/kg toutes les deux semaines (± 3 jours) au jour 1 de chaque cycle de

traitement, jusqu'à progression, toxicité inacceptable, retrait de consentement, complétion de l'étude (pouvant aller jusqu'à 104 semaines) ou décès.

La randomisation a été stratifiée selon les critères suivants : selon le poids (< 80 kg vs ≥ 80 kg) et la classification catégorisant le pronostic des cancers du rein métastatiques ou avancés selon les critères IMDC [*International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium*] (pronostic favorable vs intermédiaire vs défavorable).

Population de l'étude

Les patients inclus étaient atteints d'un carcinome rénal avancé ou métastatique à composante à cellules claires, confirmé histologiquement (y compris ceux présentant des caractéristiques sarcomatoïdes), et n'ayant reçu au maximum que deux lignes de traitement systémique antérieures.

Les principales caractéristiques des patients ont été comparables entre les 2 groupes, à l'exception d'une proportion plus élevée de patients dans le bras nivolumab SC présentant une maladie avec des caractéristiques sarcomatoïdes à l'inclusion (6,5 % vs 2,4 %), et d'une proportion également plus importante de métastases cérébrales (13,7 % contre 9,3 %). A noter que 10,9 % des patients du bras nivolumab SC avaient reçu deux lignes de traitement antérieures, contre 5,3 % dans le bras nivolumab IV.

Critères de jugement

Les co-critères de jugement pharmacocinétique principaux étaient :

- Concentration sérique moyenne du nivolumab au cours des 28 premiers jours (Cavgd28),
- Concentration sérique résiduelle à l'état d'équilibre (Cminss).

Le critère de jugement secondaire était le taux de réponse (ORR) évaluée par le BICR, défini par la proportion des patients obtenant une réponse complète ou partielle au cours du traitement avec un minimum de 6 mois de suivi.

Une analyse hiérarchisée a été réalisée sur les co-critères de jugement principaux PK (Cavgd28 et Cminss) et le critère secondaire hiérarchisé d'efficacité (ORR) selon la séquence suivante :

- Les co-critères de jugement principaux ont été testés en parallèle au seuil alpha unilatéral de 0,05, avec des intervalles de confiance bilatéraux à 90%. La non-infériorité de nivolumab SC versus nivolumab IV était conclue si la borne inférieure des IC bilatéraux à 90% des RMG pour Cavgd28 et Cminss était $\geq 0,8$.
- Si la non-infériorité était démontrée sur ces deux critères, alors le critère d'efficacité hiérarchisé (ORR) était testé au seuil alpha unilatéral de 0,025, avec des intervalles de confiance bilatéraux à 95%. Pour conclure à la non-infériorité, la borne inférieure de l'IC95% du RR devait être $\geq 0,60$.

En l'absence de méthode de contrôle du risque alpha, les autres critères de jugement notamment le taux de contrôle de la maladie (DCR), la durée de réponse (DOR), le délai avant la réponse (TTR), la survie sans progression (SSP), ainsi que la survie globale (SG)) sont considérés comme exploratoires.

➔ Résultats sur le critère de jugement principal

A la date d'extraction du 21/08/2023, nivolumab 600 mg par voie S.C. a démontré sa non-infériorité par rapport à nivolumab par voie I.V. dans la population pharmacocinétique (PK) évaluable comprenant 242 patients dans le groupe SC et 245 patients dans le groupe IV, en termes de :

- Concentration sérique moyenne de nivolumab au cours des 28 premiers jours (Cavgd28) avec un RMG de 2,098 ; IC90 % [2,001 ; 2,200] ;

- Concentration sérique résiduelle de nivolumab à l'état d'équilibre (Cminss) avec un RMG de 1,774 ; IC90 % [1,633 ; 1,927].

La borne inférieure de l'IC90 % des RMG a été supérieure à la limite de non-infériorité définie à priori de 0,8 pour ces deux critères.

Tableau 1 : Résultats des co-critères de jugements principaux (population PK) – Etude CheckMate-67T

	n	Moyenne géométrique ajustée	RMG ajustée	IC90 %
Cavgd28				
SC	242	77,373		[74,555 ; 80,297]
IV	245	36,875		[35,565 ; 38,235]
SC versus IV			2,098	[2,001 ; 2,200]
Cminss				
SC	242	122,227		[114,552 ; 130,416]
IV	245	68,901		[64,676 ; 73,402]
SC versus IV			1,774	[1,633 ; 1,927]

Cavgd28 : concentration sérique moyenne au cours des 28 premiers jours, Cminss : concentration sérique résiduelle de nivolumab à l'état d'équilibre, IC : intervalle de confiance, RMG : rapport de la moyenne géométrique.

➔ Résultats sur les critères de jugement secondaire avec gestion du risque alpha

A la date d'extraction du 21/08/2023, nivolumab 600 mg par voie S.C. a démontré sa non-infériorité par rapport à nivolumab 240 mg par voie I.V. en termes de taux de réponse objective (ORR) évalué par le BICR avec un risque relatif (RR) de 1,33 IC95 % [0,94 ; 1,87] dont la borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % a été supérieure à la limite de non-infériorité définie à priori de 0,6 pour ce critère.

Tableau 2 : Résultats de l'ORR évalué par le BICR (population randomisée) – Etude CheckMate-67T

ORR selon le BICR (RC + RP)	Nivolumab SC N=248	Nivolumab IV N=247
n (%)	60 (24,2)	45 (18,2)
[IC95%]	[19,0 ; 30,0]	[13,6 ; 23,6]
Estimation du RR, [IC95%]	1,33 [0,94 ; 1,87]	
Différence ORR, % [IC95%]	6 [-1,2 ; 13,1]	

BICR : Blinded Independent Central Review, RC : réponse complète, RP : réponse partielle, RR : ORR SC / ORR IV

➔ Résultats sur la Survie globale et autres critères de jugement secondaires non hiérarchisés

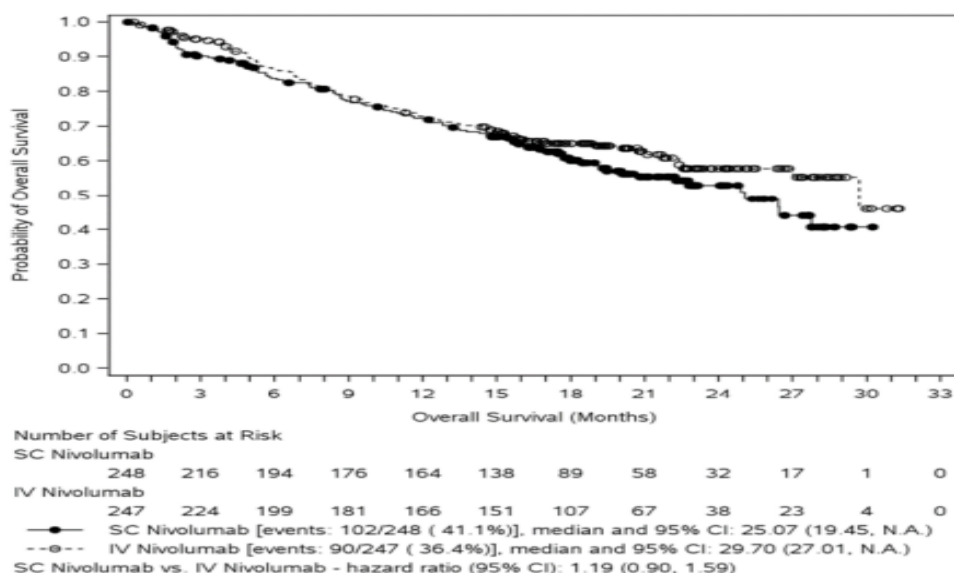
A la date d'extraction de base du 21/08/2023 avec un suivi minimum de 8 mois, le taux de contrôle de la maladie (62,9% vs 62,8%) et le délai médian avant la réponse (3,7 mois vs 3,68 mois) ont été similaires entre les deux groupes de traitement (nivolumab SC et nivolumab IV). La médiane de SSP a été de 7,23 mois IC95 % [5,13 ; 7,49] et 5,65 mois IC95 % [5,29 ; 7,39] pour le groupe nivolumab SC et nivolumab IV respectivement avec un HR de 1,06 [0,84 ; 1,34].

Les médianes sur la SG n'ont pas été atteintes avec un HR de 1.25 (IC95% : 0.89, 1.77). Un total de 134 décès a été rapporté dont 73 décès survenus (29,4 %) dans le groupe nivolumab SC, et 61 décès survenus (24,7 %) dans le groupe nivolumab IV.

La durée de la réponse tumorale a été de 14 mois IC95 % (7,52 ; NA) dans le groupe nivolumab SC mais non atteinte dans le groupe nivolumab IV (NA, IC95 % (13,9 ; NA)).

A la deuxième extraction des données du 18/03/2024 avec une durée médiane de suivi de 21,2 mois, la médiane de survie globale a été de 25,07 mois IC95% [19,45 ; NA] dans le groupe nivolumab SC et 29,7 mois IC95 % [27 ; NA] dans le groupe nivolumab IV avec un HR de 1.19 [IC95 % : 0.90, 1.59]. Dans le groupe nivolumab SC, 102 patients sur 248 (41,1 %) ont présenté un événement de décès, contre 90 patients sur 247 (36,4 %) dans le groupe nivolumab IV.

Figure 2 : Courbe de Kaplan-Meier de la survie globale - population ITT - extraction des données du 18/03/2024



Lors d'une analyse adhoc à la date d'extraction de base du 05/09/2024, le HR de la SG était de 1,08 IC95 % [0,83 ; 1,39]).

Qualité de vie

La qualité de vie des patients a été évaluée dans des analyses exploratoires à l'aide des questionnaires EQ-5D-5L, et FKSI-19. Néanmoins, compte tenu du caractère exploratoire de ces analyses, aucune conclusion formelle ne peut être tirée des résultats.

3.3 Profil de tolérance

3.3.1 Données issues de l'étude clinique CheckMate-67T

A la date d'extraction de base du 21/08/2023, la proportion de patients ayant signalé un événement indésirable (EI) était similaire dans les deux groupes de traitement (93,1 % dans le bras nivolumab SC contre 93,5 % dans le bras nivolumab IV). Dans le bras nivolumab pour administration SC, les EI de grade 3-4 rapportés chez ≥ 2 % des patients étaient l'anémie (5,7 %), l'hyperglycémie et l'hyperkaliémie (2,4 % chacune) ainsi que la dyspnée (2 %). Dans le bras nivolumab pour administration IV, les EI de grade 3-4 les plus fréquents étaient l'anémie (8,6 %), l'hypercalcémie (2,9 %), la fatigue, l'hyperglycémie et l'hyponatrémie (2 % chacun).

Une proportion plus élevée de patients était décédée au moment de la clôture des données (21/08/2023) dans le bras nivolumab SC : 29,6 % contre 24,5 % dans le bras nivolumab IV. Trois décès liés à la toxicité du médicament d'étude ont été rapportés dans le bras nivolumab SC (myopathie, colite

et myocardite), contre un seul décès dans le bras nivolumab IV (pneumopathie/pneumonie immuno-médiée).

Le profil de tolérance de la nouvelle présentation est marqué par des réactions au site de l'injection (7% vs. 0%). Cependant, aucun événement de grade 3-5 n'a été rapporté. L'incidence des EI immunomédiés a été comparable entre les deux groupes de traitement. Aucun autre nouveau signal de tolérance n'a été identifié.

L'incidence des anticorps ADA anti-nivolumab apparus sous traitement a été plus élevée dans le groupe nivolumab SC (22,8%) par rapport au groupe nivolumab IV (7,0%). Néanmoins, parmi cette proportion d'ADA, seulement 1 % étaient persistants positifs dans le groupe nivolumab SC et 0% dans le groupe nivolumab IV. La fréquence des ADA anti-rHuPH20 à l'inclusion et au cours du traitement était similaire.

Des anticorps neutralisants ont été rapportés uniquement dans le groupe nivolumab SC (1,0% pour les ADA anti-nivolumab et 2,3% pour les ADA anti-rHuPH20).

3.3.2 Données issues du PBRER et du Plan de Gestion des Risques (PGR)

Le résumé de risques de la dernière version du PGR (version 40.2 du 25 mai 2025) est présenté dans le tableau ci-dessous :

Risques importants identifiés	– Effets indésirables d'origine immunologique (incluant pneumopathie inflammatoire, colite, hépatite, néphrite et dysfonction rénale, endocrinopathie, effets indésirables cutanés et autres événements d'origine immunologique) – Réaction grave à la perfusion (forme IV seulement)
Risques importants potentiels	– Toxicité embryo-fœtale – Immunogénicité – Risque de maladie du greffon contre l'hôte (GvHD) avec nivolumab après greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques
Informations manquantes	– Patients avec insuffisance hépatique sévère et/ou insuffisance rénale sévère – Patients avec maladie auto-immune – Patients recevant déjà un traitement immunosuppresseur systémique avant le début du traitement par nivolumab – Tolérance sur le long terme chez les patients adolescents âgés de 12 ans et plus (forme IV seulement)

La Mesure Additionnelle de Réductions des Risques mise en place est une carte patient afin de sensibiliser davantage les patients sur l'apparition précoce et la gestion appropriée des risques importants identifiés d'origine immunologique.

Le PGR précise notamment que tous les EI d'origine immunologique (pneumopathies inflammatoires, colites, hépatites, néphrites ou dysfonctions rénales, endocrinopathies, à type cutané et autres effets indésirables d'origine immunologique) doivent être particulièrement bien documentés et évalués à des intervalles réguliers.

3.3.3 Données issues du RCP

Selon le RCP, « la sécurité du nivolumab administré par voie sous-cutanée était similaire au profil de sécurité connu de la formulation intraveineuse de nivolumab, avec un effet indésirable supplémentaire de réaction au site d'injection (7 % dans le bras nivolumab par voie sous-cutanée [n = 247] contre 0 % dans le bras nivolumab par voie intraveineuse [n = 245]). »

« Immunogénicité

Formulation sous-cutanée

Parmi les 202 patients traités par nivolumab en solution injectable et évaluables pour la présence d'anticorps anti-nivolumab, environ 23 % (46/202) étaient positifs au test de détection des anticorps anti-nivolumab effectué à l'aide d'un test d'électrochimiluminescence (ECL) et 1 % (2/202) présentaient des anticorps neutralisants contre le nivolumab. L'incidence des anticorps anti-hyaluronidase PH20 humaine recombinante (anti-rHuPH20) apparaissant sous traitement chez les patients traités par nivolumab en solution injectable était de 8,8 % (19/215). »

4. Discussion

Il s'agit d'une demande d'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics de la spécialité OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée.

Le laboratoire a fourni les résultats d'une étude de phase 3 (CheckMate-67T), comparative, randomisée, ouverte, multicentrique, dont l'objectif était de démontrer la non-infériorité du nivolumab administré par voie sous-cutanée (SC) par rapport au nivolumab administré par voie intraveineuse (IV) chez les patients atteints d'un carcinome rénal à cellules claires avancé ou métastatique ayant précédemment reçu au moins un traitement antérieur systémique.

A la date d'extraction de base du 21/08/2023, les résultats de l'étude CheckMate-67T ont montré une non-infériorité du nivolumab S.C. par rapport à nivolumab par voie I.V. sur les deux co-critères de jugement principaux :

- concentration sérique moyenne de nivolumab au cours des 28 premiers jours (Cavgd28) avec un RMG de 2,098 ; IC90% [2,001 ; 2,200] ;
- concentration sérique résiduelle de nivolumab à l'état d'équilibre (Cminss) avec un RMG de 1,774 ; IC90% [1,633 ; 1,927].

et sur le critère de jugement secondaire hiérarchisé :

- taux de réponse objective (ORR) avec un risque relatif (RR) de 1,33 IC95 % [0,94 ; 1,87].

Cependant la portée de ces résultats est limitée par les points suivants :

- les résultats sur la SG, bien qu'exploratoires, sont en défaveur du groupe nivolumab SC avec une médiane de SG de 25,07 mois IC95% [19,45 ; NA] dans le groupe nivolumab S.C. contre 29,7 mois IC95% [27 ; NA] dans le bras nivolumab IV avec un HR de 1.19 [IC95% : 0.90, 1.59] à la date de la deuxième extraction des données du 18/03/2024. Lors de l'analyse ad hoc réalisée à la date d'extraction de base du 05/09/2024, le HR de SG était de 1,08 (IC95 % [0,83 ; 1,39]).
- une durée de réponse tumorale en défaveur du groupe nivolumab SC avec une médiane de durée de réponse de 14 mois IC95 % (7,52 ; NA)) dans le groupe nivolumab SC mais non atteinte dans le groupe nivolumab IV (NA IC95 % (13,9 ; NA)).

5. Conclusions de la Commission de la Transparence

Considérant l'ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime que dans le périmètre de l'évaluation :

5.1 Place du médicament dans la stratégie thérapeutique

La place de OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée, est identique à celle de OPDIVO 10mg/ml (nivolu-mab) solution à diluer pour perfusion.

5.2 Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre retenu

Les comparateurs cliniquement pertinents (CCP) d'OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée, sont les mêmes que ceux identifiés pour les autres présentations d'OPDIVO 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion dans les indications concernées et remboursables (cf. avis de la Commission de la Transparence du 13/01/2016², du 03/02/2016³, du 05/10/2016⁴, du 11/01/2017⁵, du 03/05/2017⁶, du 31/01/2018⁷, du 05/12/2018⁸, du 02/06/2021⁹, du 10/07/2019¹⁰, du 22/09/2021¹¹, du 03/11/2021¹², du 02/02/2022¹³, du 23/03/2022¹⁴, du 12/10/2022^{15,16},

² Avis de la CT 13/01/2016 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome avancé (non résecable ou métastatique).

³ Avis de la CT du 03/02/2016 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules de type épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure.

⁴ Avis du 05/10/2016 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé après un traitement antérieur).

⁵ Avis de la CT du 11/01/2017 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules de type non épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure.

⁶ Avis de la CT du 03/05/2017 – OPDIVO en association à l'ipilimumab dans le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome avancé (non résecable ou métastatique).

⁷ Avis de la CT du 31/01/2018 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer épidermoïde de la tête et du cou, en rechute ou métastatique, en progression pendant ou après une chimiothérapie à base de sels de platine.

⁸ Avis de la CT du 05/12/2018 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un mélanome avec atteinte des ganglions lymphatiques ou une maladie métastatique, et ayant subi une résection complète.

⁹ Avis de la CT du 02/06/2021 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un mélanome avec atteinte des ganglions lymphatiques ou une maladie métastatique, et ayant subi une résection complète.

¹⁰ Avis de la CT du 10/07/2019 – en association à l'ipilimumab, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé de pronostic intermédiaire/défavorable.

¹¹ Avis de la CT du 22/09/2021 – OPDIVO en association au cabozantinib, dans le traitement de première ligne, au stade avancé du carcinome rénal, uniquement à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires.

¹² Avis de la CT du 03/11/2021 – OPDIVO en association à l'ipilimumab, dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN ou une instabilité microsatellitaire élevée après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, uniquement chez les patients n'ayant pas reçu d'immunothérapie antérieure.

¹³ Avis de la CT du 02/02/2022 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique, et qui présentent une maladie résiduelle après une radiochimiothérapie néoadjuvante antérieure.

¹⁴ Avis de la CT du 23/03/2022 – OPDIVO en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne de traitement, dans le traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique, de la jonction œso-gastrique ou de l'œsophage avancé ou métastatique, HER-2 négatif, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score combiné positif (CPS) ≥ 5 .

¹⁵ Avis du 12/10/2022 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints de carcinome urothélial infiltrant le muscle et à haut risque de récurrence après résection complète.

¹⁶ Avis de la CT du 12/10/2022 – OPDIVO en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne de traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résecable, récurrent ou métastatique, dont les tumeurs expriment PD-L1 $\geq 1\%$.

du 22/11/2023¹⁷, du 20/12/2023¹⁸, et du 24/09/2025¹⁹ relatifs aux spécialités d'OPDIVO 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion).

5.3 Service Médical Rendu

Le service médical rendu par OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable par voie sous cutanée, est identique à celui attribué à OPDIVO (nivolumab), solution pour perfusion par voie intraveineuse, dans les indications concernées par la demande de remboursement. L'ensemble de ces conclusions sont rappelées ci-après :

5.3.1 Mélanome

5.3.1.1 Monothérapie

- Le mélanome est un cancer cutané à fort potentiel métastatique, qui peut, lorsqu'il est avancé, se compliquer de métastases et engager le pronostic vital à court ou moyen terme.
- Il s'agit d'un traitement spécifique du mélanome à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses représentées par le vemurafenib (ZELBORAF) et le dabrafenib (TAFINLAR) chez les patients porteurs d'une mutation B-RAF, et l'ipilimumab (YERVOY), la dacarbazine (DETICENE), la fotémustine (MUPHORAN) chez les patients non porteurs d'une mutation B-RAF.
- Il s'agit d'un traitement de première ligne chez les patients non porteurs d'une mutation B-RAF. Le nivolumab est une alternative possible en première ligne chez les patients B-RAF mutés.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO 600 mg est important en « monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique) ».

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication et aux posologies de l'AMM.

¹⁷ Avis de la CT du 22/11/2023 – OPDIVO en association à l'ipilimumab chez les patients B-RAF non muté, en 1^{ère} ligne chez les patients ECOG 0 ou 1, dont la tumeur est B-RAF muté, sans métastase cérébrale active.

¹⁸ Avis de la CT du 20/12/2023 – OPDIVO en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus, atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC et ayant subi une résection complète.

¹⁹ Avis de la CT du 24/09/2025 – OPDIVO dans le traitement de première ligne chez des patients adultes atteints d'un cancer colorectal (CRC) métastatique et non résécables d'emblée avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) ou une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H)

5.3.1.2 Association OPDIVO/YERVOY

Chez les B-RAF non muté,

- ➔ Le mélanome est un cancer cutané à fort potentiel métastatique, qui peut, lorsqu'il est avancé, se compliquer de métastases et engager le pronostic vital à court ou moyen terme.
- ➔ Il s'agit d'un traitement spécifique du mélanome à visée curative.
- ➔ Le rapport efficacité/effets indésirables de l'association nivolumab + ipilimumab est moyen.
- ➔ Il existe des alternatives médicamenteuses dans cette indication.
- ➔ L'association nivolumab + ipilimumab est un traitement de première ligne uniquement dans la population des patients avec ECOG 0 ou 1, atteints d'un mélanome au stade avancé B-RAF non muté et ne présentant pas de métastase cérébrale active.

La Commission considère que le service médical rendu par l'association OPDIVO plus ipilimumab est :

- **important uniquement en 1^{ère} ligne chez les patients ECOG 0 ou 1, dont la tumeur est B-RAF non muté, ne présentant pas de métastase cérébrale active et avec une administration dans des centres disposant d'une réanimation médicale polyvalente ou équivalente ;**
- **insuffisant dans les autres cas pour une prise en charge par la solidarité nationale**

La Commission donne un avis favorable à l'inscription d'OPDIVO en association à l'ipilimumab sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités uniquement :

- **dans la population suivante : en 1^{ère} ligne de traitement du mélanome au stade avancé chez des patients ECOG 0 ou 1, dont la tumeur est B-RAF non muté et qui ne présentent pas de métastase cérébrale active, et**
- **avec une administration dans des centres disposant d'une réanimation médicale polyvalente.**

Chez les B-RAF muté,

Au même titre que OPDIVO/YERVOY (nivolumab/ipilimumab) dans l'indication en 1^{ère} ligne chez les patients ECOG 0 ou 1, dont la tumeur est B-RAF non muté, sans métastase cérébrale active :

- ➔ Le mélanome est un cancer cutané à fort potentiel métastatique, qui peut, lorsqu'il est avancé, se compliquer de métastases et engager le pronostic vital à court ou moyen terme.
- ➔ Il s'agit d'un traitement spécifique du mélanome à visée curative.
- ➔ Le rapport efficacité/effets indésirables de l'association nivolumab + ipilimumab est moyen.
- ➔ Il existe des alternatives médicamenteuses dans cette indication.
- ➔ L'association nivolumab + ipilimumab est un traitement de première ligne dans la population des patients avec ECOG 0 ou 1, atteints d'un mélanome au stade avancé B-RAF muté et sans métastase cérébrale active.

➔ **Intérêt de santé publique**

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère qu'au même titre que chez les patients B-RAF non muté, le service médical rendu par l'association OPDIVO/YERVOY (nivolumab/ipilimumab) est important en 1^{ère} ligne chez les patients ECOG 0 ou 1, dont la tumeur est B-RAF muté, sans métastase cérébrale active.

5.3.2 Traitement adjuvant du mélanome

5.3.2.1 Mélanome type IIB/IIC

- Le mélanome est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un médicament à visée préventive à l'égard de la récurrence.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il existe des alternatives médicamenteuses à ce stade de la prise en charge (KEYTRUDA (pembrolizumab)).
- Il s'agit d'un traitement de première intention dans le cadre d'une thérapeutique adjuvante à la chirurgie.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO 600 mg (nivolumab) est important dans l'indication : « en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC et ayant subi une résection complète ».

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités de OPDIVO (nivolumab) en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC et ayant subi une résection complète.

5.3.2.2 Mélanome avec atteinte des ganglions lymphatiques ou une maladie métastatique, et ayant subi une résection complète

- Le mélanome est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un traitement spécifique du mélanome à haut risque de récurrence à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il existe des alternatives médicamenteuses.
- Il s'agit d'un traitement adjuvant de première intention des patients adultes atteints d'un mélanome avec atteinte des ganglions lymphatiques ou une maladie métastatique, et ayant subi une résection complète.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO 600 mg (nivolumab) est important dans l'indication : « en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un mélanome avec atteinte des ganglions lymphatiques ou une maladie métastatique, et ayant subi une résection complète ».

La Commission donne un avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication et aux posologies de l'AMM.

5.3.3 Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC)

5.3.3.1 CBNPC de type Épidermoïde

- ➔ Le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de type épidermoïde est une affection grave qui engage le pronostic vital.
- ➔ Il s'agit d'un traitement spécifique du CBNPC de type épidermoïde à visée curative.
- ➔ Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- ➔ Il existe des alternatives médicamenteuses.
- ➔ Il s'agit d'un traitement de seconde ligne.

➔ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO 600 mg (nivolumab) est important dans l'indication « traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non-à-petites cellules (CBNPC) de type épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure ».

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication « traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non-à-petites cellules (CBNPC) de type épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure » et à la posologie de l'AMM.

5.3.3.2 CBNPC de type non épidermoïde

- ➔ Le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de type non épidermoïde est une affection grave qui engage le pronostic vital.
- ➔ Il s'agit d'un traitement spécifique du CBNPC de type non épidermoïde à visée curative.
- ➔ Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- ➔ Il existe des alternatives médicamenteuses.
- ➔ Il s'agit d'un traitement de deuxième ligne après échec d'une chimiothérapie à base de sels de platine.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO 600 mg (nivolumab) est important, uniquement chez les patients en bon état général (ECOG 0 ou 1) dans l'indication « traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non-à-petites cellules (CBNPC) de type non épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure ».

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication « traitement des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non-à-petites cellules (CBNPC) de type non épidermoïde localement avancé ou métastatique après une chimiothérapie antérieure », uniquement chez les patients en bon état général (ECOG 0 ou 1) et à la posologie de l'AMM.

5.3.4 Carcinome à cellules rénales (CCR)

5.3.4.1 Monothérapie

- Le cancer du rein à cellules claires est une affection grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un traitement spécifique du cancer du rein à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il existe des alternatives médicamenteuses.
- Il s'agit d'un traitement de seconde ligne.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO est important uniquement dans le traitement du cancer du rein à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires au stade avancé après échec d'un traitement antérieur par anti-VEGF.

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans le traitement du cancer du rein à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires au stade avancé après échec d'un traitement antérieur par anti-VEGF et à la posologie de l'AMM.

5.3.4.2 En association à ipilimumab

- Le cancer du rein à cellules claires est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un traitement spécifique du cancer du rein à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires à visée curative.

- Le rapport efficacité/effets indésirables de l'association OPDIVO / YERVOY est important uniquement dans le carcinome rénal à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires.
- Il existe des alternatives thérapeutiques.
- Il s'agit d'un traitement de 1^{ère} ligne.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg en association à l'ipilimumab n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par l'association OPDIVO (nivolumab) / YERVOY (ipilimumab) est important uniquement dans le traitement de 1^{ère} ligne au stade avancé du carcinome rénal à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires de pronostic intermédiaire ou défavorable.

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans le traitement de 1^{ère} ligne au stade avancé du carcinome rénal à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires de pronostic intermédiaire ou défavorable et aux posologies de l'AMM.

5.3.4.3 En association au cabozantinib

- Le cancer du rein à cellules claires est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un traitement spécifique du cancer du rein à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables à court terme de l'association CABOMETYX (cabozantinib) / OPDIVO (nivolumab) est important uniquement dans le carcinome rénal à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires. Dans le traitement du carcinome rénal à cellules non claires, compte tenu de l'absence de données disponibles, son rapport efficacité/effets indésirables n'est pas établi.
- Il existe des alternatives thérapeutiques.
- Il s'agit d'un traitement de première ligne.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg (nivolumab) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par l'association CABOMETYX/OPDIVO (cabozantinib/nivolumab) est :

- important uniquement dans le traitement de 1^{ère} ligne, au stade avancé, du carcinome rénal à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires,
- insuffisant pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale dans le traitement de première ligne, au stade avancé, du carcinome rénal avec une histologie autre qu'à cellules claires compte tenu de l'absence de données.

La Commission donne :

- un avis favorable à l'inscription pour les deux spécialités CABOMETYX et OPDIVO sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et uniquement pour la spécialité CABOMETYX sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux dans : le traitement de 1^{ère} ligne, au stade avancé, du carcinome rénal à cellules claires ou comportant un contingent de cellules claires et aux posologies de l'AMM,
- un avis défavorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans le traitement de 1^{ère} ligne, au stade avancé, du carcinome rénal avec une histologie autre qu'à cellules claires et aux posologies de l'AMM.

5.3.5 Cancer épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN)

- Le carcinome des voies aérodigestives supérieures est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un médicament à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il existe des alternatives médicamenteuses en deuxième ligne après échec d'une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine.
- Il s'agit d'un traitement de deuxième ligne après échec d'une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO 600 mg (nivolumab) est important dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde des voies aérodigestives supérieures en progression pendant ou après une chimiothérapie à base de sels de platine.

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer épidermoïde de la tête et du cou en progression pendant ou après une chimiothérapie à base de sels de platine » et à la posologie de l'AMM.

5.3.6 Traitement adjuvant du carcinome urothélial

- Le carcinome urothélial est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- La spécialité OPDIVO (nivolumab) est un médicament à visée préventive à l'égard de la récurrence.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il n'existe pas de traitement médicamenteux préconisé à ce stade de la prise en charge dans l'indication restreinte (surveillance clinique et radiologique).
- Il s'agit d'un traitement adjuvant à la chirurgie.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique par rapport aux présentations déjà inscrites.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO (nivolumab) est important uniquement dans l'indication restreinte : en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints de carcinome urothélial infiltrant le muscle (CUIM) à haut risque de récurrence après exérèse complète, dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$:

- ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante ;
- ou n'ayant pas reçu de chimiothérapie néoadjuvante et non éligibles/ou ayant refusé une chimiothérapie adjuvante à base de cisplatine.

Dans le reste du champ de l'indication de l'AMM, la Commission considère que le service médical rendu est insuffisant pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale.

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication restreinte : en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints de carcinome urothélial infiltrant le muscle (CUIM) à haut risque de récurrence après exérèse complète, dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$:

- ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante ;
- ou n'ayant pas reçu de chimiothérapie néoadjuvante et non éligibles/ou ayant refusé une chimiothérapie adjuvante à base de cisplatine. »

5.3.7 Cancer colorectal (CRC) avec déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) ou instabilité microsatellitaire élevée (MSI H)

5.3.7.1 Traitement de première ligne du cancer colorectal

- Le cancer colorectal métastatique est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un médicament à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important chez les patients non résécables d'emblée.
- Il existe des alternatives thérapeutiques.
- L'association OPDIVO (nivolumab) / YERVOY (ipilimumab) est un traitement de première ligne chez les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique et non résécable d'emblée avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR).

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission considère que le service médical rendu de l'association OPDIVO (nivolumab) / YERVOY (ipilimumab) est :

- important uniquement en traitement de première ligne chez des patients adultes atteints d'un cancer colorectal (CRC) métastatique et non résécables d'emblée avec une

déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) ou une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H),

- insuffisant pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale dans les autres situations de l'AMM.

La Commission donne un avis :

- favorable à l'inscription de OPDIVO (nivolumab) / YERVOY (ipilimumab) sur la liste des spécialités remboursables aux assurés uniquement dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) non résécables d'emblée et aux posologies de l'AMM,
- défavorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans les autres situations de l'AMM.

5.3.7.2 Traitement du cancer colorectal métastatique après une chimiothérapie antérieure combinée à base de fluoropyrimidine

- ➔ Le cancer colorectal métastatique est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- ➔ L'association OPDIVO/YERVOY (nivolumab/ipilimumab) est à visée curative.
- ➔ Son rapport efficacité/effets indésirables est modéré, compte tenu des données cliniques limitées issues d'une étude de phase non comparative, et des incertitudes liées notamment :
 - à l'absence de données de comparaison robuste alors qu'il existait des comparateurs cliniquement pertinents disponibles,
 - aux données préliminaires à l'appui dans une population hétérogène en termes de lignes de traitement (le sous-groupe de 2ème ligne a concerné que 27 patients),
 - aux faiblesses méthodologiques de la comparaison indirecte fournie,
 - à la toxicité marquée par une incidence des événements indésirables (EI) graves rapportée chez plus de la moitié des patients (55%) et celle des EI de grades ≥ 3 chez près deux tiers des patients (62%).
- ➔ Il existe des alternatives thérapeutiques.
- ➔ L'association OPDIVO/YERVOY (nivolumab/ipilimumab) constitue une alternative en tant que traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN ou une instabilité microsatellitaire élevée après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, uniquement chez les patients n'ayant pas reçu d'immunothérapie antérieure.

➔ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par l'association OPDIVO/YERVOY (nivolumab/ipilimumab) est :

- modéré dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN ou une instabilité microsatellitaire élevée après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, chez les patients n'ayant pas reçu d'immunothérapie antérieure.

- insuffisant pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale dans les autres situations (patients ayant reçu une immunothérapie antérieure).

La Commission donne un avis favorable à l'inscription de cette association sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN ou une instabilité microsatellitaire élevée après une association antérieure de chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, chez les patients n'ayant pas reçu d'immunothérapie antérieure et aux posologies de l'AMM.

La Commission donne un avis défavorable à l'inscription de cette association sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans les autres situations (patients ayant reçu une immunothérapie antérieure).

5.3.8 Carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO)

- Le cancer de l'œsophage est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un médicament à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il existe des alternatives thérapeutiques.
- OPDIVO (nivolumab) en association à une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de sels de platine est un traitement en 1ère ligne dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résécable, récurrent ou métastatique dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO (nivolumab) dans le cadre de l'association à une chimiothérapie est important dans l'indication de l'AMM.

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication « OPDIVO est indiqué en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage avancé non résécable, récurrent ou métastatique dont les cellules tumorales expriment PD-L1 au seuil $\geq 1\%$ » et aux posologies de l'AMM.

5.3.9 Traitement adjuvant du cancer de l'œsophage ou de la jonction œso-gastrique (CO ou CJOG)

- Le cancer de l'œsophage ou de la jonction œso-gastrique est une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un médicament à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est :

- important en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique et qui ont une maladie résiduelle après une radiochimiothérapie néoadjuvante antérieure et une résection complète (R0 post-chirurgie) dans les 4 à 16 semaines.
 - non établi dans les autres situations faute de données disponibles.
- Il n'existe pas d'alternatives thérapeutiques.
- Il s'agit d'un traitement de 1ère intention.

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO (nivolumab) est :

- important uniquement en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique et qui ont une maladie résiduelle après une radiochimiothérapie néoadjuvante antérieure et une résection complète (R0 post-chirurgie) dans les 4 à 16 semaines,
- insuffisant pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale dans les autres situations, faute de données.

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités uniquement en monothérapie dans le traitement adjuvant des patients adultes atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique et qui ont une maladie résiduelle après une radiochimiothérapie néoadjuvante antérieure et une résection complète (R0 post-chirurgie) dans les 4 à 16 semaines.

La Commission donne un avis défavorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans les autres situations.

5.3.10 Adénocarcinome gastrique, de la jonction œsogastrique (JOG) ou de l'œsophage

- Les adénocarcinomes gastriques, de la jonction œsogastrique ou de l'œsophage avancés non résécables ou métastatiques sont des maladies graves qui engagent le pronostic vital.
- Il s'agit d'un médicament à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est important.
- Il existe des alternatives thérapeutiques.
- OPDIVO (nivolumab) en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, est un traitement de première ligne chez les patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique, de la jonction œso-gastrique ou de l'œsophage avancé ou métastatique, HER-2 négatif, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score positif combiné (Combined Positive Score : CPS) ≥ 5 .

→ Intérêt de santé publique

OPDIVO 600 mg n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

La Commission considère que le service médical rendu par OPDIVO 600 mg (nivolumab) en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne, est important dans le traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique, de la jonction œso-gastrique ou de l'œsophage avancé ou métastatique, HER-2 négatif, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score positif combiné (Combined Positive Score : CPS) ≥ 5 .

La Commission donne un avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication suivante « en association à une chimiothérapie combinée à base de fluoropyrimidine et de sels de platine, en première ligne, dans le traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique, de la jonction œso-gastrique ou de l'œsophage avancé ou métastatique, HER-2 négatif, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score positif combiné (Combined Positive Score : CPS) ≥ 5 » et aux posologies de l'AMM.

5.4 Amélioration du Service Médical Rendu

Cette spécialité est un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations de OPDIVO 10 mg/mL, solution pour perfusion (IV), déjà inscrites.

5.5 Population cible

L'introduction d'OPDIVO (nivolumab) 600 mg, solution injectable pour administration par voie sous-cutanée, n'est pas de nature à modifier les populations cibles déjà estimées par la Commission pour OPDIVO (nivolumab) 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, dans les indications concernées par la présente demande (cf. avis de la Commission de la Transparence du 13/01/2016, du 03/02/2016, du 05/10/2016, du 11/01/2017, du 03/05/2017, du 31/01/2018, du 05/12/2018, du 02/06/2021, du 10/07/2019, du 22/09/2021, du 03/11/2021, du 02/02/2022, du 23/03/2022, du 12/10/2022, du 22/11/2023, du 20/12/2023, et du 24/09/2025 relatifs aux spécialités d'OPDIVO 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion).

5.6 Demande de données

La Commission souhaite être destinataire des résultats finaux notamment la Survie globale de l'étude CheckMate-67T (résultats attendus pour 2026) dans un délai max de 1 an.

Sur la base de ces résultats attendus dans un délai maximal de 1 an, la Commission jugera de l'opportunité de réévaluer le médicament.

5.7 Autres recommandations de la Commission

→ Conditionnement

Le conditionnement est adapté aux conditions de prescription selon les indications, la posologie et la durée de traitement.